

Dengue: global situation, surveillance and progress – 2024 update

Background and global context

Dengue fever is a mosquito-borne viral infection caused by 4 serotypes of the *Flavivirus* genus (DENV-1 to DENV-4). Dengue is one of the fastest-spreading vector-borne diseases worldwide and a significant cause of illness and hospitalization in tropical and subtropical regions. Transmission occurs mainly through bites of infected *Aedes aegypti* and *A. albopictus* mosquitoes, which breed in densely populated urban areas.

Over the past 5 decades, dengue has extended from fewer than 10 endemic countries in the 1970s to more than 130 today, with the highest burdens in Latin America, Asia and parts of Africa. Rapid urbanization, inadequate water and waste management and increased mobility have enabled the proliferation of *Aedes* mosquitoes, while climate variation has extended transmission into some temperate regions.

More than half the global population now lives in areas at risk of dengue infection. The disease continues to strain health systems in low- and middle-income countries, where it drives recurrent outbreaks, high hospitalization rates and economic losses. Transmission peaks during rainy seasons but is increasingly sustained year-round in many urban centres.

Temperature and rainfall patterns strongly influence mosquito development and viral replication, while unplanned urban expansion and high population density sustain human-vector contact. International travel facilitates the movement of dengue virus serotypes and genotypes, occasionally leading to outbreaks in previously unaffected areas. Dengue remains substantially underreported and is frequently misdiagnosed, because early symptoms are non-specific, the majority of cases are asymptomatic, and diagnostic capacity is limited in many settings. The actual burden is therefore likely to be much higher than that reported, complicating preparedness and resource planning.

There is no specific antiviral treatment, and management consists of early diagnosis, hydration and clinical monitoring. Prevention requires integrated measures, combining vector control, surveillance, vaccination and community engagement. Currently, only one vaccine – Qdenga (TAK-003) – has been approved. It is used in several countries for young people aged 6–16 years in high-transmission areas.

Global epidemiological overview – 2024

In 2024, dengue was transmitted at unprecedented levels worldwide. WHO received reports of 14 434 584 cases, including 7 718 585 laboratory-confirmed, 52 738 severe and 11 201 deaths in all 6 regions. Transmission surged

Dengue: situation mondiale, surveillance et progrès – mise à jour 2024

Généralités et contexte mondial

La dengue est une infection virale transmise par les moustiques, causée par 4 sérotypes du genre *Flavivirus* (DENV-1 à DENV-4). Il s'agit de l'une des maladies à transmission vectorielle qui se propage le plus rapidement dans le monde et elle est une cause majeure de morbidité et d'hospitalisation dans les régions tropicales et subtropicales. Elle se transmet principalement par la piqûre de moustiques *Aedes aegypti* et *A. albopictus* infectés, qui se reproduisent dans les zones urbaines densément peuplées.

Au cours des 50 dernières années, la dengue, qui était endémique dans moins de 10 pays dans les années 1970, s'est étendue à plus de 130 pays aujourd'hui, l'Amérique latine, l'Asie et certaines régions d'Afrique concentrant la plus lourde charge de morbidité. L'urbanisation rapide, la mauvaise gestion de l'eau et des déchets et la mobilité accrue ont favorisé la prolifération des moustiques *Aedes*, tandis que la transmission s'est étendue à certaines régions tempérées en raison des variations climatiques.

Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans des zones à risque d'infection par le virus de la dengue. La maladie continue de peser lourdement sur les systèmes de santé dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, où elle provoque des épidémies récurrentes, des taux d'hospitalisation élevés et des pertes économiques. La transmission culmine pendant la saison des pluies, mais dans de nombreux centres urbains, elle tend à se maintenir toute l'année.

Les températures et les précipitations influent fortement sur le développement des moustiques et la réplication du virus, tandis que l'urbanisation non planifiée et la forte densité de population favorisent le contact humain-vecteur. Les voyages internationaux facilitent la circulation des sérotypes et génotypes du virus de la dengue, entraînant parfois des épidémies dans des zones auparavant indemnes de la maladie. La dengue reste largement sous-notifiée et elle souvent mal diagnostiquée, car les premiers symptômes ne sont pas spécifiques, la majorité des cas sont asymptomatiques et la capacité de diagnostic est limitée dans de nombreux contextes. La charge réelle de la dengue est donc probablement bien plus élevée que celle établie sur la base des données communiquées, ce qui complique la préparation et la planification des ressources.

Il n'existe pas de traitement antiviral spécifique; la prise en charge consiste à réaliser un diagnostic précoce, à assurer l'hydratation des patients et à effectuer un suivi clinique. La prévention repose sur des mesures intégrées combinant la lutte antivectorielle, la surveillance, la vaccination et la mobilisation communautaire. Actuellement, un seul vaccin, le Qdenga (TAK-003), est homologué. Il est utilisé dans plusieurs pays pour vacciner les jeunes âgés de 6 à 16 ans vivant dans des zones à forte transmission.

Vue d'ensemble de la situation épidémiologique dans le monde – 2024

En 2024, la transmission de la dengue a atteint des niveaux sans précédent dans le monde entier. Au total, 14 425 912 cas ont été notifiés à l'OMS, dont 7 723 378 cas confirmés en laboratoire, 52 738 cas sévères et 11 177 décès dans les 6 Régions.

between February and May and remained high in several areas throughout the final quarter, reflecting the growing climate sensitivity of the virus and the increasing presence of *Aedes* mosquitoes in urban environments.

Table 1 illustrates the distribution of reported, confirmed, severe and fatal cases by country. The Region of the Americas accounted for more than 90% of the global total of cases. Brazil alone reported over 10 million cases and 6321 deaths. Other countries with large epidemics included Argentina (581 559 cases), Mexico (558 846), Colombia (320 982), Paraguay (295 785), Peru (271 531), Guatemala (188 585) and Honduras (177 209). In South-East Asia, Indonesia (257 271 cases) and India (232 425) also experienced extensive outbreaks linked to monsoon-related transmission cycles.

The South-East Asia and Western Pacific regions collectively contributed more than 1 million cases, primarily in Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia and Viet Nam. The African Region recorded a sharp rise, with notable outbreaks in Burkina Faso and Cabo Verde. In the Eastern Mediterranean Region, recurrent epidemics occurred in Pakistan, while limited autochthonous transmission was reported in southern Europe and Réunion. Overall, 2024 marked the highest global dengue burden ever recorded, with cases reported in more than 100 countries (Figure 1). The data demonstrate both the record magnitude of transmission and continuing expansion of the virus into new geographical and climatic zones.

Regional overviews

The global dengue burden in 2024 was unevenly distributed by WHO region, reflecting differences in ecology, the capacity of health systems and population exposure. This distribution is illustrated by the concentration of dengue in the Americas and Asia and its growing reach into Africa and parts of Europe, consistent with global trends in vector expansion and climate suitability.

African region

In the African Region, dengue remains an underrecognized and underreported health threat. The actual burden is difficult to quantify because of limited surveillance and diagnostic capacity. The lack of routine laboratory testing and integrated arboviral monitoring systems in many countries leads to frequent misclassification of dengue as malaria or other febrile illnesses.

Despite these limitations, outbreaks have been documented in more than 12 countries during the past decade. Recurring epidemics have been reported in Burkina Faso, Kenya, Nigeria and the United Republic of Tanzania, while island nations such as Cabo Verde and Seychelles have confirmed local transmission. *A. aegypti* is widespread in urban and peri-urban settings, and *A. albopictus* has been identified in several locations, further increasing transmission potential.

La transmission a augmenté entre février et mai et est restée élevée dans plusieurs régions tout au long du dernier trimestre, signe d'une sensibilité croissante du virus de la dengue au climat et d'une présence accrue des moustiques *Aedes* dans les milieux urbains.

Le Tableau 1 illustre la répartition des cas signalés, confirmés, sévères et mortels par pays. La Région des Amériques a représenté plus de 90% du nombre total de cas dans le monde. Le Brésil à lui seul a signalé plus de 10 millions de cas et 6321 décès. D'autres pays ont connu des épidémies de grande ampleur, notamment l'Argentine (581 559 cas), le Mexique (558 846 cas), la Colombie (320 982 cas), le Paraguay (295 785 cas), le Pérou (271 531 cas), le Guatemala (188 585 cas) et le Honduras (177 209 cas). En Asie du Sud-Est, l'Indonésie (257 271 cas) et l'Inde (232 425 cas) ont également connu d'importantes épidémies liées aux cycles de transmission associés à la mousson.

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est et dans la Région du Pacifique occidental, plus d'un million de cas ont été recensés, principalement au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, en Malaisie et au Viet Nam. La Région africaine a enregistré une forte augmentation du nombre de cas, avec des épidémies notables signalées au Burkina Faso et à Cabo Verde. Dans la Région de la Méditerranée orientale, des épidémies récurrentes se sont produites au Pakistan et au Yémen, tandis qu'une transmission autochtone limitée a été observée dans le sud de l'Europe et à la Réunion. Dans l'ensemble, l'année 2024 a connu la plus forte charge mondiale de dengue jamais enregistrée, avec des cas notifiés dans plus de 100 pays (Figure 1). Les données montrent à la fois l'ampleur record de la transmission et l'extension continue du virus de la dengue à de nouvelles zones géographiques et climatiques.

Situation dans les Régions

En 2024, la répartition de la charge de la dengue était inégale selon les Régions de l'OMS, en raison de différences en matière d'écologie, de capacités des systèmes de santé et d'exposition des populations. Cette répartition montre une concentration de la dengue dans les Amériques et en Asie et sa propagation croissante en Afrique et dans certaines parties de l'Europe, qui correspondent aux tendances de la propagation des vecteurs et à celles des conditions climatiques qui leur sont favorables, observées à l'échelle mondiale.

Région africaine

Dans la Région africaine, la dengue reste une menace sanitaire mal reconnue et sous-notifiée. La charge réelle est difficile à quantifier en raison des capacités limitées en matière de surveillance et de diagnostic. L'absence de tests systématiques en laboratoire et de systèmes intégrés de surveillance des arbovirus dans de nombreux pays conduit souvent à une classification erronée de la dengue, qui est confondue avec le paludisme ou d'autres maladies fébriles.

Des épidémies ont néanmoins été documentées dans plus de 12 pays au cours de la dernière décennie. Des épidémies récurrentes ont été signalées au Burkina Faso, au Kenya, au Nigéria et en République unie de Tanzanie, tandis que des nations insulaires telles que Cabo Verde et les Seychelles ont confirmé l'existence d'une transmission locale. *A. aegypti* est largement répandu dans les zones urbaines et périurbaines, et *A. albopictus* a été identifié dans plusieurs endroits, ce qui augmente encore le potentiel de transmission.

Table 1 **Global distribution of dengue cases by country and by WHO region, 2024 (as reported by 10 December 2025)**
Tableau 1 **Répartition des cas de dengue dans le monde, par pays et Région OMS, 2024 (données en date du 10 décembre 2025)**

WHO region – Région OMS	Countries, areas and territories – Pays, zones et territoires	Number of reported dengue cases ^a – Nombre de cas de dengue signalés ^a	Number of reported confirmed dengue cases ^b – Nombre de cas de dengue confirmés signalés ^b	Number of reported dengue deaths ^c – Nombre de décès causés par la dengue signalés ^c
African Region – Région africaine		157 000	40 457	140
	Angola	86	0	1
	Benin – Bénin	41	3	1
	Burkina Faso	73 808	23 235	94
	Cabo Verde	25 290	2 696	1
	Cameroon – Cameroun	57	0	0
	Central African Republic – République centrafricaine	207	31	0
	Côte d'Ivoire	6 134	879	5
	Eritrea – Érythrée	14 679	0	0
	Ethiopia – Éthiopie	4 016	2 435	0
	Ghana	1 163	0	0
	Guinea – Guinée	2	1	0
	Kenya	4 443	0	0
	Liberia – Libéria	45	0	0
	Mali	9 556	1 492	12
	Mauritania – Mauritanie	3 640	83	0
	Mauritius – Maurice	9 917	9 348	5
	Niger	58	0	12
	Sao Tome and Principe – Sao Tomé-et-Principe	32	32	0
	Senegal – Sénégal	1 208	68	9
	Seychelles	2 583	154	0
	Sierra Leone	1	0	0
	United Republic of Tanzania – République-Unie de Tanzanie	34	0	0
Region of the Americas – Région des Amériques		13 063 434	6 997 321	8 431
	Anguilla	5	5	0
	Antigua and Barbuda –Antigua-et-Barbuda	169	17	0
	Argentina – Argentine	581 559	188 410	408
	Aruba	88	9	0
	Barbados – Barbade	1 133	887	0
	Belize – Bélize	1 148	791	0
	Bermuda – Bermudes	3	2	0
	Bolivia (Plurinational State of) – Bolivie (État plurinational de)	58 877	12 792	29
	Bonaire, Sint Eustatius and Saba – Bonaire, Saint-Eustache et Saba	207	134	0
	Brazil – Brésil	10 266 017	5 973 340	6 321
	British Virgin Islands – Îles Vierges Britanniques	139	98	0
	Cayman Islands – Îles Caïman	9	9	0

Table 1 (continued) – Tableau 1 (suite)

WHO region – Région OMS	Countries, areas and territories – Pays, zones et territoires	Number of reported dengue cases ^a – Nombre de cas de dengue signalés ^a	Number of reported confirmed dengue cases ^b – Nombre de cas de dengue confirmés signalés ^b	Number of reported dengue deaths ^c – Nombre de décès causés par la dengue signalés ^c
	Chile – Chili	157	157	0
	Colombia – Colombie	320 982	230 369	229
	Costa Rica	31 259	1 301	7
	Cuba	985	985	0
	Curacao – Curaçao	262	228	0
	Dominican Republic – République dominicaine	10 300	1 293	35
	Ecuador – Équateur	61 400	61 400	75
	El Salvador – Salvador	8 552	764	9
	French Guiana – Guyane française	16 141	8 601	8
	Grenada – Grenade	798	46	0
	Guadeloupe	11 025	1 088	0
	Guatemala	188 585	6 009	188
	Guyana	46 306	11 428	8
	Honduras	177 209	10 008	160
	Jamaica – Jamaïque	2 034	43	1
	Martinique	7 371	227	0
	Mexico – Mexique	558 846	125 160	478
	Montserrat	3	3	0
	Nicaragua	92 022	11 335	1
	Panama	37 231	32 077	52
	Paraguay	295 785	37 829	129
	Peru – Pérou	271 531	267 377	261
	Puerto Rico – Porto Rico	6 088	4 943	8
	Saint Barthélemy	173	16	0
	Saint Kitts and Nevis – Saint-Kitts-et-Nevis	253	64	0
	Saint Lucia – Sainte-Lucie	432	432	0
	Saint Martin (French part) – Saint Martin (côté français)	624	5	0
	Saint Vincent and the Grenadines – Saint-Vincent-et-Grenadines	971	971	0
	Sint Maarten (Dutch part) – Saint Martin (côté hollandais)	144	144	0
	Suriname	95	87	3
	Trinidad and Tobago – Trinité-et-Tobago	2 004	2 004	19
	Turks and Caicos Islands – Îles Turques et Caïques	117	38	0
	United States Virgin Islands – Îles Vierges américaines	185	185	0
	United States of America – États-Unis d'Amérique	3 071	3 071	0
	Uruguay	1 139	1 139	2
Eastern Mediterranean Region – Région de la Méditerranée orientale		96 884	6 126	26
	Afghanistan	4 689	1 278	2
	Djibouti	1 678	0	0
	Iran (Islamic Republic of) – Iran (République islamique d')	796	0	0

WHO region – Région OMS	Countries, areas and territories – Pays, zones et territoires	Number of reported dengue cases ^a – Nombre de cas de dengue signalés ^a	Number of reported confirmed dengue cases ^b – Nombre de cas de dengue confirmés signalés ^b	Number of reported dengue deaths ^c – Nombre de décès causés par la dengue signalés ^c
	Pakistan	58 670	0	0
	Somalia – Somalie	555	140	0
	Sudan – Soudan	10 817	0	8
	Yemen – Yémen	19 679	4 708	16
European Region – Région européenne		1 603	68	4
	France	85	0	0
	Italy – Italie	213	0	0
	Mayotte	68	68	0
	Réunion	1 227	0	4
	Spain – Espagne	10	0	0
South-East Asia Region – Région de l'Asie du Sud-Est		798 690	674 613	2 400
	Bangladesh	101 214	101 214	557
	Bhutan – Bhoutan	213	17	0
	India – Inde	232 425	200 334	233
	Indonesia – Indonésie	257 271	257 271	1 461
	Maldives	3 294	3 246	2
	Myanmar	6 388	6 388	13
	Nepal – Népal	41 865	0	15
	Sri Lanka	49 877	0	24
	Thailand – Thaïlande	104 681	104 681	87
	Timor-Leste	1 462	1 462	8
Western Pacific Region – Région du Pacifique occidental		316 973	0	200
	Australia – Australie	2 381	0	0
	Cambodia – Cambodge	18 983	0	46
	China – Chine	24 330	0	0
	Fiji – Fidji	6 238	0	0
	French Polynesia – Polynésie française	147	0	0
	Lao People's Democratic Republic – République démocratique populaire lao	19 486	0	11
	Malaysia – Malaisie	122 423	0	117
	Micronesia, Federated States of – Micronésie (Etats fédérés de)	43	0	0
	New Caledonia – Nouvelle-Calédonie	16	0	0
	Northern Mariana Islands – Îles Mariannes du Nord	1	0	0
	Palau – Palaos	4	0	0
	Samoa	473	0	0
	Singapore – Singapour	13 655	0	0
	Solomon Islands – Îles Solomon	125	0	0
	Tokelau – Tokélaou	4	0	0

WHO region – Région OMS	Countries, areas and territories – Pays, zones et territoires	Number of reported dengue cases ^a – Nombre de cas de dengue signalés ^a	Number of reported confirmed dengue cases ^b – Nombre de cas de dengue confirmés signalés ^b	Number of reported dengue deaths ^c – Nombre de décès causés par la dengue signalés ^c
	Tonga	14	0	0
	Tuvalu	1	0	0
	Vanuatu	138	0	0
	Viet Nam	108 433	0	26
	Wallis and Futuna – Wallis-et-Futuna	78	0	0
Global – Ensemble du monde		14 434 584	7 718 585	11 201

^a Number of reported dengue cases – number of cases recorded and reported to WHO. This includes clinically diagnosed and laboratory confirmed cases. – Nombre de cas dengue signalés – nombre de cas enregistrés et signalés à l'OMS. Cela inclut les cas cliniquement diagnostiqués et les cas confirmés en laboratoire.

^b Number of reported confirmed dengue cases – number of cases tested and confirmed as dengue. – Nombre de cas dengue confirmés signalés – nombre de cas testés et confirmés comme des cas de dengue.

^c There is no clear distinction between countries that reported zero death and those that did not report on this indicator. In this table, zero death may therefore sometimes indicate that the information was not available. – Il n'y a pas de distinction claire entre les pays qui ont signalé zéro décès et ceux qui n'ont pas communiqué d'informations sur cet indicateur. Dans ce tableau, zéro décès peut donc parfois indiquer que l'information n'était pas disponible.

In 2024, the African Region reported 157 000 dengue cases, a marked increase over previous years. Of these, 40 457 were laboratory-confirmed, 1 856 were classified as severe, and 140 deaths were reported, underscoring dengue's rising clinical impact. Transmission was documented in 13 countries: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Ethiopia, Kenya, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, Sao Tomé and Príncipe, Senegal and Seychelles.

Burkina Faso experienced one of the most significant outbreaks, with 73 808 cases and 94 deaths, and confirmed co-circulation of DENV-1, DENV-2 and DENV-3. Similar evidence of multiple serotypes was reported in Côte d'Ivoire and Senegal, suggesting that dengue is becoming increasingly established in West Africa.

Region of the Americas

The Region of the Americas experienced an unprecedented surge in dengue transmission in 2024, far surpassing the already high levels reported in 2023. The number of dengue cases recorded during the first half of the year alone exceeded the total typically observed during full epidemic cycles, marking an unparalleled trajectory in the Region. In total, 13 063 434 dengue cases were reported in 2024, as compared with approximately 4.1 million in 2023 – representing an increase of the overall burden of more than three times. Of these cases, 6 997 321 were laboratory confirmed, 23 177 were classified as severe, and 8 431 deaths were documented, making 2024 the deadliest year on record for dengue in the Americas.

Brazil had the highest number, reporting 10 266 017 suspected cases and 6 321 deaths. Transmission occurred in nearly all states, with hyperendemic circulation of all 4 dengue virus serotypes. Heavy rainfall associated with El Niño conditions, high population density and uneven vector control measures contributed to Brazil's explosive outbreak. Argentina also recorded its largest epidemic to date, with 581 559 cases and

En 2024, la Région africaine a signalé plus de 157 000 cas de dengue, une augmentation notable par rapport aux années précédentes. Parmi ceux-ci, 40 457 ont été confirmés en laboratoire, 1 856 ont été classées comme sévères et 140 décès ont été signalés, soulignant l'aggravation de l'impact clinique de la dengue. La transmission a été documentée dans 13 pays: Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Kenya, Mali, Maurice, Mauritanie, Niger, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal et Seychelles.

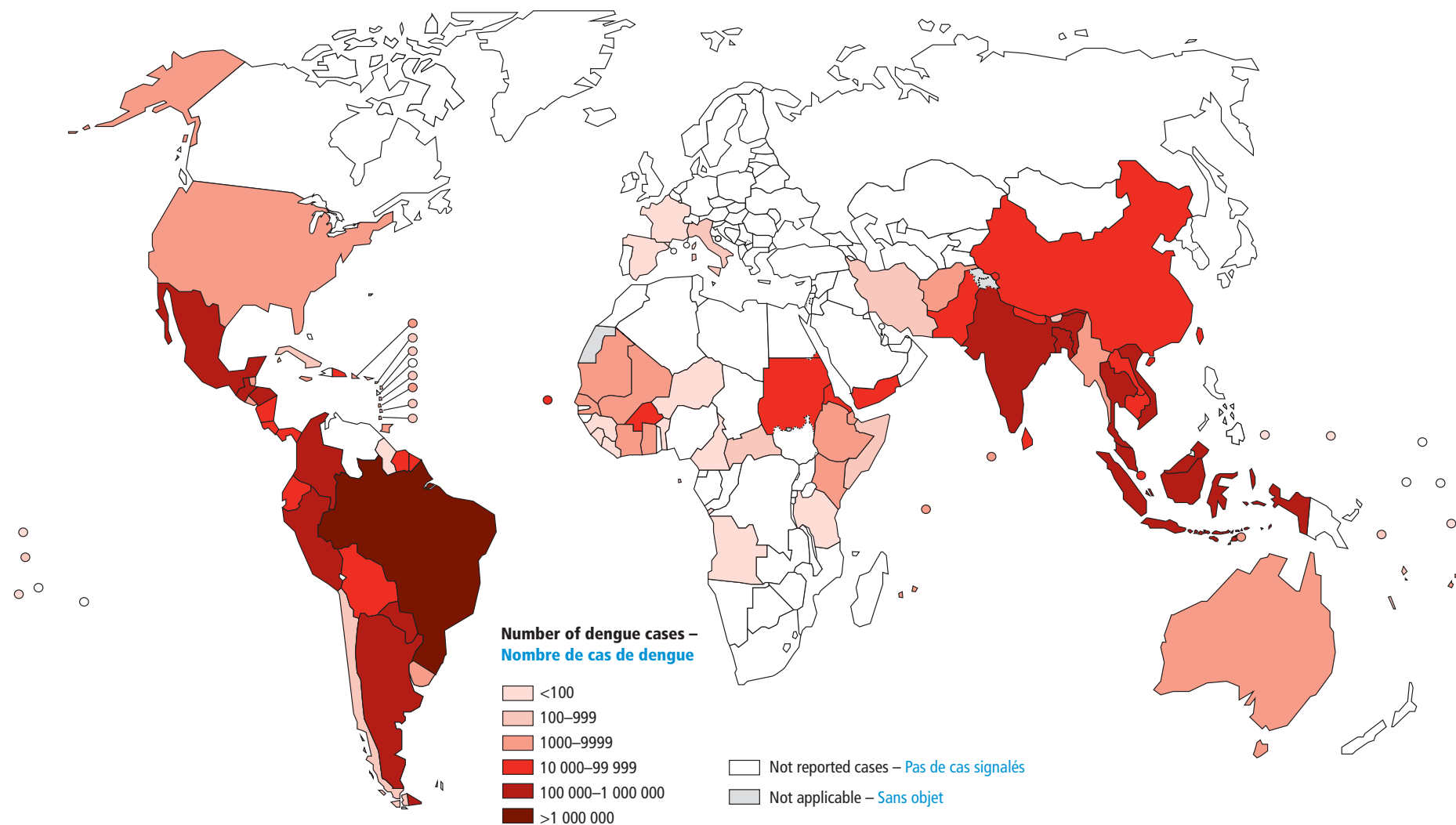
Le Burkina Faso a connu l'une des épidémies les plus importantes, avec 73 808 cas et 94 décès, et a confirmé la cocirculation de DENV-1, DENV-2 et DENV-3. Des preuves de la présence de multiples sérotypes ont été établies en Côte d'Ivoire et au Sénégal, suggérant que la dengue s'implante de plus en plus en Afrique de l'Ouest.

Région des Amériques

La Région des Amériques a connu une hausse sans précédent de la transmission de la dengue en 2024, dépassant largement les niveaux déjà élevés enregistrés en 2023. Le nombre de cas de dengue recensés au cours du seul premier semestre a dépassé le total généralement observé pendant des cycles épidémiques complets, marquant une trajectoire inédite dans la Région. Au total, 13 063 434 cas de dengue ont été signalés en 2024, contre environ 4,1 millions en 2023 – soit une charge de la maladie qui a plus que triplé. Parmi ces cas, 6 997 321 ont été confirmés en laboratoire, 23 177 ont été classés comme sévères, et 8 431 décès ont été documentés, faisant de 2024 l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour la dengue dans les Amériques.

Le Brésil a été l'épicentre de l'épidémie, avec 10 266 017 cas suspects et 6 321 décès signalés. La transmission a touché presque tous les États, avec une circulation hyperendémique des 4 sérotypes du virus de la dengue. Les fortes précipitations associées au phénomène El Niño, la forte densité de population et les mesures inégales de lutte antivectorielle ont contribué à l'explosion de l'épidémie au Brésil. L'Argentine a également enregistré sa plus grande épidémie à ce jour, avec 581 559 cas

Map 1 **Global distribution of dengue cases, by country, 2024 (as reported by 10 December 2025)**
 Carte 1 **Répartition des cas de dengue dans le monde, par pays, 2024 (données en date du 10 décembre 2025)**



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. © World Health Organization (WHO), 2025. All rights reserved. – Les limites et appellations figurant sur cette carte ou les désignations employées n'impliquent de la part de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Les lignes en pointillés sur les cartes représentent des frontières approximatives dont le tracé peut ne pas avoir fait l'objet d'un accord définitif. © Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2025. Tous droits réservés.

Data source: World Health Organization. – Source des données: Organisation mondiale de la Santé.

Map production: Malaria & Neglected Tropical Diseases (MNT), World Health Organization. – Production de la carte: Paludisme & maladies tropicales négligées (MNT), Organisation mondiale de la Santé.

408 deaths in 19 of the country's 24 provinces, including major urban centres such as Buenos Aires, Córdoba and Santa Fe. Paraguay (295 785 cases, 129 deaths), Colombia (320 982 cases, 229 deaths) and Peru (271 531 cases, 261 deaths) also reported historically high caseloads, placing sustained pressure on national health systems.

All 4 dengue virus serotypes circulated widely across the Region in 2024. Brazil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico, El Salvador and Panama confirmed co-circulation of all 4 serotypes, illustrating the hyperendemic nature of dengue in the Americas. For the first time in a decade, DENV-3 predominated in Mexico, Central America and parts of the Caribbean during the second half of the year. Such serotype shifts are epidemiologically important because they heighten the risk of severe disease among populations with previous exposure to other serotypes.

The regional crisis was compounded by concurrent transmission of other arboviruses, including Zika and chikungunya, which complicated clinical diagnosis and further strained public health infrastructure. Hospitals in Argentina, Brazil and Paraguay reported bed shortages, and primary care services struggled to manage sustained numbers of febrile cases. The Americas' experience in 2024 illustrates the convergence of climatic, ecological and social drivers that can accelerate dengue transmission to historic levels along with serotype variations and severe secondary cases.

South-East Asia Region

In the South-East Asia Region, the hyperendemic nature of dengue, with all 4 serotypes circulating concurrently, continues to amplify the risk of severe outcomes. Children and adolescents remain disproportionately affected, with high levels of secondary infections in these age groups. Periodic outbreaks place additional strain on health-care systems that are already operating with limited resources. Urbanization without adequate water and waste management infrastructure sustains mosquito breeding, while seasonal monsoons drive predictable peaks in transmission.

In 2024, the Region experienced a substantial dengue burden, with 798 690 reported cases, 674 613 laboratory confirmed infections, 27 705 severe cases and 2400 deaths. The epidemic curve rose steadily during the first half of the year, culminating in a sharp surge in the monsoon season, particularly between August and November, in line with climatic patterns that favour mosquito proliferation.

Bangladesh reported 101 214 cases and 557 deaths, a significant outbreak. The prolonged rainy season and recurrent flooding created ideal mosquito breeding environments, particularly in densely populated urban areas such as Dhaka. Indonesia also faced a severe epidemic, with 257 271 cases and 1461 deaths, while India (232 425 cases, 233 deaths) and Thailand (104 681 cases, 87 deaths) recorded elevated dengue activity consistent with the Region's recurrent seasonal pattern.

et 408 décès dans 19 des 24 provinces du pays, notamment dans de grands centres urbains tels que Buenos Aires, Córdoba et Santa Fe. La Colombie (320 982 cas, 229 décès), le Paraguay (295 785 cas, 129 décès) et le Pérou (271 531 cas, 261 décès) ont également rapporté un nombre de cas historiquement élevé, qui ont soumis les systèmes de santé nationaux à une forte pression.

Les 4 sérotypes du virus de la dengue ont largement circulé dans la Région en 2024. Le Brésil, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique et le Panama ont confirmé la cocirculation des 4 sérotypes, illustrant la nature hyperendémique de la dengue dans les Amériques. Pour la première fois en dix ans, le DENV-3 a été prédominant en Amérique centrale, dans certaines parties des Caraïbes et au Mexique au cours du second semestre. Ces changements de sérotypes sont importants sur le plan épidémiologique, car ils augmentent le risque de forme sévère de la maladie parmi les populations qui ont déjà été exposées à d'autres sérotypes.

La crise régionale a été aggravée par la transmission simultanée d'autres arbovirus, notamment le virus Zika et le virus du chikungunya, ce qui a compliqué le diagnostic clinique et mis à rude épreuve les infrastructures de santé publique. Les hôpitaux en Argentine, au Brésil et au Paraguay ont signalé une pénurie de lits, et les services de soins primaires ont eu du mal à gérer le nombre élevé de cas fébriles. L'expérience des Amériques en 2024 illustre la convergence de facteurs climatiques, écologiques et sociaux qui peuvent amplifier la transmission de la dengue et la porter à des niveaux historiques.

Région de l'Asie du Sud-Est

Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, la nature hyperendémique de la dengue, due à la circulation simultanée des 4 sérotypes, continue d'amplifier le risque d'issue sévère pour les patients. Les enfants et les adolescents restent disproportionnellement touchés et, dans ces tranches d'âge, les taux d'infections secondaires sont élevés. Les épidémies périodiques mettent une pression supplémentaire sur les systèmes de santé qui fonctionnent déjà avec des ressources limitées. L'urbanisation sans infrastructures adéquates de gestion de l'eau et des déchets favorise la reproduction des moustiques, tandis que les moussons saisonnières entraînent des pics prévisibles de transmission.

En 2024, la charge de la dengue a été importante dans la Région, avec 782 049 cas signalés, 674 613 infections confirmées en laboratoire, 27 705 cas sévères et 2376 décès. La courbe épidémique a augmenté de manière régulière au cours du premier semestre, pour culminer pendant la saison de la mousson où l'on a observé une forte recrudescence, en particulier entre août et novembre, au moment où les conditions climatiques favorisent la prolifération des moustiques.

Le Bangladesh a connu une épidémie importante, avec 101 214 cas et 557 décès. La saison des pluies prolongée et les inondations récurrentes ont créé des conditions idéales pour la reproduction des moustiques, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées telles que Dhaka. L'Indonésie a également été confrontée à une épidémie sévère, avec 257 271 cas et 1461 décès, tandis que l'Inde (232 425 cas, 233 décès) et la Thaïlande (104 681 cas, 87 décès) ont enregistré une activité élevée de la dengue, conforme au schéma saisonnier récurrent de la Région.

The persistence of hyperendemic transmission in many South-East Asian countries highlights the entrenched nature of dengue in the region. Multi-serotype circulation, monsoon-driven surges and climate-sensitive drivers continue to position South-East Asia as one of the world's principal epicentres of dengue.

European region

Dengue is not endemic in the WHO European Region, and most reported cases are related to travel. The Region's epidemiological profile is defined by imported infections, sporadic local transmission in temperate zones and endemic outbreaks in European overseas territories in the Indian Ocean. As climate conditions evolve and the distribution of *A. albopictus* extends northwards, the European Region is becoming increasingly vulnerable to localized outbreaks.

Most dengue cases in the WHO European Region in 2024 occurred in Réunion (1227 cases) and Mayotte (68 cases), two French overseas departments in the Indian Ocean, where dengue is endemic. These islands experience year-round *A. aegypti* activity and limited vector control capacity. In Madeira, where *A. aegypti* has been established since 2005, isolated dengue cases were reported in early 2025. Although no major outbreak occurred, surveillance remained high after the 2012 epidemic. Madeira's climatic suitability for mosquito breeding, particularly in Funchal, makes it a potential hotspot for future localized outbreaks during the summer months.

Sporadic local transmission was documented across mainland Europe in 2024, with 85 cases in France, 10 in Spain and 213 in Italy, consistent with trends observed in recent years. These episodes demonstrate that entomological and epidemiological surveillance should be established in southern Europe. In addition to dengue, imported and occasional local cases of Zika and chikungunya continue to be detected. *A. albopictus* is well established in several countries, indicating the importance of integrated arboviral surveillance.

Eastern Mediterranean region

In the WHO Eastern Mediterranean Region, dengue outbreaks were reported in both fragile, conflict-affected countries and those with stronger systems, associated with unusually heavy rains linked to climate variation. *A. aegypti* and, in some areas, *A. albopictus* have been detected in most countries.

In 2024, the Region reported 96 884 cases, including 6126 laboratory-confirmed and 26 deaths. Although the burden remained lower than in the Americas or South-East Asia, dengue activity increased notably, driven by climatic and ecological shifts, rapid urbanization and the spread of *Aedes* mosquitoes into previously non-endemic areas. These trends pose a growing concern for fragile health systems in which surveillance and response capacity remain limited.

La persistance d'une transmission hyperendémique dans de nombreux pays d'Asie du Sud-Est souligne le caractère profondément enraciné de la dengue dans la Région. La circulation de plusieurs sérotypes, les pics liés à la mousson et les facteurs climatiques continuent de faire de l'Asie du Sud-Est l'un des principaux épicentres de la dengue dans le monde.

Région européenne

La dengue n'est pas endémique dans la Région européenne de l'OMS, et la plupart des cas signalés sont liés aux voyages. Le profil épidémiologique de la Région est caractérisé par des infections importées, des transmissions locales sporadiques dans les zones tempérées et des épidémies endémiques dans les territoires européens d'outre-mer de l'océan Indien. À mesure que les conditions climatiques évoluent et que la répartition de *A. albopictus* s'étend vers le nord, la Région européenne devient de plus en plus vulnérable à des flambées localisées.

La plupart des cas de dengue dans la Région européenne de l'OMS en 2024 se sont produits à La Réunion (1227 cas) et à Mayotte (68 cas), deux départements français d'outre-mer situés dans l'océan Indien, où la dengue est endémique. Sur ces îles, *A. aegypti* est actif toute l'année et les capacités de lutte antivectorielle sont limitées. À Madère, où *A. aegypti* s'est implanté depuis 2005, des cas isolés de dengue ont été signalés au début de l'année 2025. Bien qu'aucune épidémie majeure n'ait eu lieu, le niveau de surveillance est resté élevé après l'épidémie de 2012. Le climat de Madère, propice à la reproduction des moustiques, en particulier à Funchal, en fait un point chaud potentiel où de futures flambées épidémiques localisées pourraient se produire pendant les mois d'été.

Une transmission locale sporadique a été documentée dans toute l'Europe continentale en 2024, avec 10 cas signalés en Espagne, 85 en France, et 213 en Italie, ce qui correspond aux tendances observées ces dernières années. Ces épisodes démontrent la nécessité de mettre en place une surveillance entomologique et épidémiologique dans le sud de l'Europe. En plus de la dengue, des cas importés et des cas autochtones occasionnels d'infection à virus Zika et de chikungunya continuent d'être détectés. *A. albopictus* étant bien implanté dans plusieurs pays, une surveillance intégrée des arbovirus s'impose.

Région de la Méditerranée orientale

Dans la Région OMS de la Méditerranée orientale, des épidémies de dengue, associées à des pluies exceptionnellement abondantes liées aux variations climatiques, ont été signalées à la fois dans des pays fragiles touchés par des conflits et dans des pays dotés de systèmes plus robustes. *A. aegypti* et, dans certaines régions, *A. albopictus* ont été détectés dans la plupart des pays.

En 2024, la Région a notifié 104 853 cas, dont 10 919 confirmés en laboratoire et 26 décès. Bien que la charge soit restée inférieure à celle des Amériques ou de l'Asie du Sud-Est, l'activité de la dengue a augmenté de manière notable sous l'effet des changements climatiques et écologiques, de l'urbanisation rapide et de la propagation des moustiques *Aedes* dans des zones où la maladie n'était pas endémique auparavant. Ces tendances suscitent une préoccupation croissante pour les systèmes de santé fragiles, dont les capacités de surveillance et de riposte restent limitées.

Pakistan accounted for most cases (58 670), concentrated in Balochistan, Punjab and Khyber Pakhtunkhwa provinces. Such recurrent epidemics have intensified due to climate variation, population density and water storage practices.

In a significant development, the Islamic Republic of Iran reported its first locally acquired dengue cases in 2024. On 14 June, the Ministry of Health confirmed 2 infections in Bandar-Lengeh, Hormozgan Province, linked to *A. aegypti* transmission. By mid-July 2024, 12 locally acquired cases had been identified, marking the country's first documented dengue transmission and reflecting both established vector presence and increased population movement from endemic areas.

Western Pacific region

The Western Pacific Region continues to experience a high burden of mosquito-borne arboviral diseases, particularly dengue, which remains endemic in 23 countries, including Cambodia, Lao People's Democratic Republic, Philippines and Viet Nam, and also in Pacific Island countries and areas. The hyperendemic circulation of all 4 dengue virus serotypes in parts of the Region contributes to recurrent epidemics and a sustained public health burden.

The most recent surveillance data in 2024 indicated that 316 973 dengue cases and 200 deaths were reported in the Region. This reflects the cyclical nature of dengue in the Western Pacific, where seasonal weather fluctuations, high population density and gaps in urban infrastructure influence transmission dynamics.

In April 2024, Samoa declared a dengue outbreak, with 473 cases and no deaths, exemplifying the vulnerability of small island states, where even modest outbreaks can strain health services. Between January and December 2024, Malaysia recorded 122 423 cases and 117 deaths, while Viet Nam reported 108 433 cases and 26 deaths, among the highest national totals in the Region.

Although many countries in the Region have well-established dengue surveillance systems, underreporting due to limited diagnostic capacity in rural and remote areas remains a challenge. The increasing frequency and magnitude of outbreaks in Pacific Island countries show dengue's capacity to overwhelm small, resource-constrained health systems where national response capacity can quickly be exceeded.

Surveillance and reporting

Underreporting and diagnostic gaps remain major barriers to understanding the true burden of dengue, and the surge in 2024 exposed further weaknesses in surveillance. Many endemic countries struggled to consolidate data from fragmented systems, particularly from private health facilities, leading to gaps in situational awareness. Laboratory confirmation also remained uneven, with limited capacity in rural and resource-constrained areas despite the record number of cases.

Le Pakistan représentait la majorité des cas (58 670), concentrés dans les provinces du Baloutchistan, du Pendjab et du Khyber Pakhtunkhwa. Ces épidémies récurrentes se sont intensifiées en raison des variations climatiques, de la densité de population et des pratiques de stockage de l'eau.

Fait marquant, la République islamique d'Iran a signalé ses premiers cas de dengue autochtones en 2024. Le 14 juin, le Ministère de la santé a confirmé 2 infections à Bandar-Lengeh, dans la province d'Hormozgan, liées à la transmission du virus par *A. aegypti*. À la mi-juillet 2024, 12 cas autochtones avaient été identifiés, marquant la première transmission documentée de dengue dans le pays et reflétant à la fois la présence établie du vecteur et l'augmentation des mouvements de population en provenance de zones d'endémie.

Région du Pacifique occidental

Dans la Région du Pacifique occidental, la charge des arboviroses transmises par les moustiques demeure élevée, en particulier la dengue, qui reste endémique dans 23 pays, notamment au Cambodge, aux Philippines, en République démocratique populaire lao et au Viet Nam, ainsi que dans des pays et zones insulaires du Pacifique. La circulation hyperendémique des 4 sérotypes du virus de la dengue dans certaines parties de la Région contribue à la récurrence des épidémies et au fardeau persistant que cela représente pour la santé publique.

D'après les données de surveillance les plus récentes, 316 973 cas de dengue et 200 décès ont été signalés dans la Région en 2024. Cela reflète la nature cyclique de la dengue dans le Pacifique occidental, où les fluctuations saisonnières du climat, la forte densité de population et les lacunes des infrastructures urbaines influent sur la dynamique de transmission.

En avril 2024, le Samoa a déclaré une épidémie de dengue, avec 473 cas et aucun décès, illustrant la vulnérabilité des petits États insulaires, où même des épidémies d'ampleur modeste peuvent mettre à rude épreuve les services de santé. Entre janvier et décembre 2024, la Malaisie a enregistré 122 423 cas et 117 décès, tandis que le Viet Nam a notifié 108 433 cas et 26 décès – des chiffres nationaux parmi les plus élevés de la Région.

Bien que de nombreux pays de la Région disposent de systèmes de surveillance de la dengue bien établis, la sous-notification due à des capacités de diagnostic limitées dans les zones rurales et reculées reste un problème. La fréquence et l'ampleur croissantes des épidémies dans les pays insulaires du Pacifique montrent que la dengue peut submerger les petites structures de santé aux ressources limitées, dont les capacités de riposte nationales peuvent être rapidement dépassées.

Surveillance et notification

La sous-notification et les lacunes en matière de diagnostic demeurent des obstacles majeurs à la compréhension de la charge réelle de la dengue, et la recrudescence observée en 2024 a mis en évidence les faiblesses de la surveillance. De nombreux pays d'endémie ont eu du mal à rassembler les données provenant de systèmes fragmentés, en particulier celles des établissements de santé privés, conduisant à une compréhension incomplète de la situation. En outre, la confirmation en laboratoire demeure inégale, les capacités étant limitées dans les zones rurales et aux ressources restreintes, malgré le nombre record de cas enregistrés.

Entomological surveillance was similarly inconsistent. Even during the major outbreaks of 2024, indices such as the Breteau index were collected irregularly and often could not be compared among countries. Although data on insecticide resistance are increasingly available through WHO-coordinated monitoring, few countries have integrated the findings into operational decision-making.

Extension of early warning and response systems (EWARS) improves early detection in several countries with severe outbreaks. Although the evaluations showed more timely alerts, the scale of transmission in 2024 revealed persistent challenges in ensuring that early warnings trigger rapid preparedness and response.

Progress and innovation

With the introduction of new preventive tools, such as vector control with *Wolbachia* and Qdenga vaccine, several Member States made tangible progress in clinical case management in 2024. Updated national guidelines emphasized early recognition, standardized patient assessment and improved clinical protocols, helping to reduce case fatality when effectively applied. In mid-2025, WHO released updated global clinical management guidelines for arboviral diseases, reflecting lessons from the 2024 dengue surge and integrating experience from outbreaks of Zika, chikungunya and yellow fever.¹ The guidance harmonizes diagnostic and case management practices for different arboviruses and promotes the use of point-of-care tools to strengthen clinical decision-making.

Forecasting and early warning systems improved significantly in 2024. Several countries in the Americas and Asia integrated meteorological and population mobility data into their EWARS platforms, improving outbreak prediction and resource pre-positioning. WHO's Dengue Surveillance Dashboard² consolidated national data during the Grade 3 emergency, enhancing regional and global situational awareness.

Innovations in vector control also progressed. Large-scale trial releases of *Wolbachia*-infected mosquitoes in Indonesia resulted in substantial reductions in dengue incidence, reinforcing confidence in biological control. More studies are under way.

Use of the Qdenga (TAK-003) vaccine increased after new regulatory approvals, creating new opportunities for prevention in both children and adults.

La surveillance entomologique a également manqué de cohérence. Même pendant les épidémies majeures de 2024, les indices tels que l'indice de Breteau n'ont pas été collectés de manière systématique et n'ont souvent pas pu être comparés entre les pays. Bien que la disponibilité des données sur la résistance aux insecticides progresse grâce à la surveillance coordonnée par l'OMS, peu de pays ont intégré ces résultats dans leur prise de décisions opérationnelles.

Le déploiement des systèmes de signalement précoce, d'alerte et de riposte (EWARS) a amélioré la détection précoce dans plusieurs pays touchés des épidémies sévères. Toutefois, si les évaluations ont montré que les alertes étaient plus rapides, l'ampleur de la transmission en 2024 a révélé des difficultés persistantes pour traduire les alertes précoces en mesures de préparation et de riposte rapides.

Progrès et innovation

Grâce à l'introduction de nouveaux outils de prévention, tels que la lutte antivectorielle utilisant la bactérie *Wolbachia* et le vaccin Qdenga, plusieurs États Membres ont réalisé des progrès tangibles dans la prise en charge clinique des cas en 2024. Les directives nationales mises à jour ont mis l'accent sur l'identification précoce des cas, l'évaluation standardisée des patients et l'amélioration des protocoles cliniques; lorsqu'elles sont appliquées efficacement, ces directives contribuent à réduire le taux de létalité. À la mi-2025, l'OMS a publié des lignes directrices mondiales actualisées pour la prise en charge clinique des arboviroses, qui tiennent compte des enseignements tirés de la recrudescence de la dengue en 2024 et intègrent l'expérience acquise lors des épidémies de maladie à virus Zika, de chikungunya et de fièvre jaune.¹ Ces lignes directrices harmonisent les pratiques de diagnostic et de prise en charge des cas pour différents arbovirus et encouragent l'utilisation d'outils sur le lieu des soins pour renforcer la prise de décision clinique.

Les systèmes de prévision et d'alerte précoce se sont nettement améliorés en 2024. Plusieurs pays des Amériques et d'Asie ont intégré des données météorologiques et des données sur la mobilité des populations dans leurs plateformes EWARS, améliorant ainsi la prévision des épidémies et le prépositionnement des ressources. Le tableau de bord de la surveillance de la dengue établi par l'OMS² a regroupé les données nationales pendant l'urgence de niveau 3, ce qui a permis de mieux appréhender la situation aux niveaux régional et mondial.

Les innovations en matière de lutte antivectorielle ont également progressé. Les essais à grande échelle de lâchers de moustiques infectés par *Wolbachia* en Indonésie ont permis de réduire sensiblement l'incidence de la dengue, renforçant ainsi la confiance dans la lutte biologique. D'autres études sont en cours.

L'utilisation du vaccin Qdenga (TAK-003) s'est accrue à la suite de nouvelles autorisations réglementaires, créant de nouvelles possibilités de prévention chez les enfants et les adultes.

¹ WHO guidelines for clinical management of arboviral diseases: dengue, chikungunya, Zika and yellow fever. Geneva: World Health Organization; 2025 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240111110>, accessed November 2025).

² Global dengue surveillance dashboard. Geneva: World Health Organization; 2024 (https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue_global/, accessed October 2025).

¹ WHO guidelines for clinical management of arboviral diseases: dengue, chikungunya, Zika and yellow fever. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2025 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240111110>, consulté en novembre 2025).

² Global dengue surveillance dashboard. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2024 (https://worldhealthorg.shinyapps.io/dengue_global/, consulté en octobre 2025).

Community participation remained a critical complement to public health action. In Argentina and Viet Nam, school campaigns and neighbourhood clean-up drives supported vector control, and mobile applications and social media were used to mobilize citizens and strengthen surveillance during outbreaks.

The situation in 2024 underscored the sensitivity of dengue to climate variation, as record transmission coincided with El Niño-linked weather anomalies. This prompted closer collaboration between the health and meteorological sectors, advancing integration of climate information into outbreak preparedness and planning.

Global response to dengue

The record dengue burden of 2024 placed extraordinary pressure on health systems and demonstrated the importance of coordinated global action. WHO and partners reinforced international frameworks and technical support mechanisms to address both emergency response and long-term control.

At strategic level, the NTD Road Map 2021–2030³ identified dengue as a priority disease requiring integrated, multisectoral approaches. WHO launched the Global Arbovirus Initiative (GLAI)⁴ in 2022 to strengthen global capacity for early detection, real-time surveillance and rapid response to dengue, Zika, chikungunya and yellow fever. The 2024 surge reaffirmed the value of GLAI in supporting Member States to expand EWARS, improve data sharing and coordinate cross-border action.

Regionally, the Grade 3 dengue emergency declared between December 2023 and December 2024 activated WHO's highest incident management level, mobilizing coordination among all 6 regions. The regional offices worked with countries to deploy experts, distribute emergency supplies and enhance cross-border collaboration through regional EWARS platforms. This signalled a shift from reactive response to proactive programmatic management.⁵ The challenge ahead is to sustain momentum, translating the emergency mobilization of 2023–2024 into long-term investment, stronger surveillance and equitable access to innovations that can reduce dengue's global impact. Vector control continues to be challenged by insecticide resistance and the lack of sustainable control measures. Although use of monitoring frameworks is increasing, resistance data are still rarely used to guide operational decisions.

La participation communautaire est restée un complément essentiel à l'action de santé publique. En Argentine et au Viet Nam, des campagnes dans les écoles et des opérations de nettoyage dans les quartiers ont soutenu la lutte antivectorielle, et les applications mobiles et les médias sociaux utilisés ont permis de mobiliser les citoyens et de renforcer la surveillance pendant les épidémies.

La situation en 2024 a mis en évidence la sensibilité de la dengue aux variations climatiques, car la transmission record qui a été constatée a coïncidé avec des anomalies météorologiques liées à El Niño. Cela a incité les secteurs de la santé et de la météorologie à collaborer plus étroitement, favorisant l'intégration des informations climatiques dans la préparation et la planification en cas d'épidémie.

Riposte mondiale à la dengue

Le niveau record de la charge de la dengue en 2024 a exercé une pression extraordinaire sur les systèmes de santé et montré l'importance d'une action mondiale coordonnée. L'OMS et ses partenaires ont renforcé les cadres internationaux et les mécanismes d'appui technique à la fois pour répondre aux situations d'urgence et pour mener une lutte contre la dengue à long terme.

Au niveau stratégique, la Feuille de route pour les MTN 2021–2030³ a identifié la dengue comme une maladie prioritaire nécessitant des approches intégrées et multisectorielles. L'OMS a lancé l'Initiative mondiale de lutte contre les arbovirus⁴ en 2022 afin de renforcer les capacités mondiales de détection précoce, de surveillance en temps réel et de riposte rapide à la dengue, à la maladie à virus Zika, au chikungunya et à la fièvre jaune. La recrudescence de 2024 a réaffirmé l'utilité de cette initiative pour aider les États Membres à étendre le système EWARS, à améliorer le partage des données et à coordonner les actions transfrontalières.

Au niveau régional, l'urgence de niveau 3 liée à la dengue, déclarée entre décembre 2023 et décembre 2024, a déclenché le niveau de gestion des incidents le plus élevé de l'OMS, impliquant une coordination entre les 6 Régions. Les bureaux régionaux ont travaillé avec les pays pour déployer des experts, distribuer des fournitures d'urgence et renforcer la collaboration transfrontalière grâce aux plateformes régionales EWARS. Cela a marqué le passage d'une réponse réactive à une gestion programmatique proactive.⁵ Le défi à relever consiste à maintenir cette dynamique, en traduisant la mobilisation d'urgence de 2023–2024 par des investissements à long terme, une surveillance renforcée et un accès équitable aux innovations qui peuvent réduire l'impact mondial de la dengue. La lutte antivectorielle reste difficile en raison de la résistance aux insecticides et de l'absence de mesures de lutte durables. Bien que l'utilisation des cadres de surveillance progresse, les données sur la résistance sont encore rarement utilisées pour orienter les décisions opérationnelles.

³ Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: a road map for neglected tropical diseases 2021–2030. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://iris.who.int/handle/10665/338565>). License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO; accessed November 2025).

⁴ Global Arbovirus Initiative. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/03/31/default-calendar/global-arbovirus-initiative>, accessed November 2025).

⁵ Global strategic preparedness, readiness and response plan for dengue and other Aedes-borne arboviruses. Geneva: World Health Organization; 2024 (<https://www.who.int/publications/m/item/global-strategic-preparedness-readiness-and-response-plan-for-dengue-and-other-aedes-borne-arboviruses>, accessed November 2025).

³ Lutter contre les maladies tropicales négligées pour atteindre les objectifs de développement durable: feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021–2030. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2021 (<https://iris.who.int/items/e005ea4c-1fd8-4506-8423-85d21312d799>). License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, consulté en novembre 2025).

⁴ Global Arbovirus Initiative. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2022 (<https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/03/31/default-calendar/global-arbovirus-initiative>, consulté en novembre 2025).

⁵ Global strategic preparedness, readiness and response plan for dengue and other Aedes-borne arboviruses. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2024 (<https://www.who.int/publications/m/item/global-strategic-preparedness-readiness-and-response-plan-for-dengue-and-other-aedes-borne-arboviruses>, consulté en novembre 2025).

Remaining challenges

The response to dengue remains constrained by systemic weaknesses in primary health care. Rural and peri-urban facilities, often the first points of health contact, have persistent shortages of trained staff, diagnostics and essential supplies. These gaps delay the detection and management of severe cases, and the 2024 surge exposed how quickly hospitals and supply chains can be overwhelmed.

Sustaining community engagement is another challenge. Outbreak-driven campaigns in 2024 mobilized large numbers of volunteers, but participation waned once emergencies ended. Continuous investment in management of containers, clean-up drives and education on schools are needed to maintain impact between outbreaks.

The transboundary spread of dengue highlights the need for stronger regional coordination. Simultaneous outbreaks in neighbouring countries indicate the limits of fragmented national responses. Timely data-sharing, harmonized case definitions and joint vector control initiatives are critical to improve preparedness and response across borders.

Editorial

The record dengue burden of 2024 marked a turning point in the global trajectory of arboviral diseases. Over 14 million cases and 11 thousand deaths were reported in the 6 WHO regions, making 2024 the year of the most extensive, severe burden. Transmission was widespread and prolonged, extending beyond traditional seasonal peaks. Concurrent circulation of all 4 serotypes, shifts in dominant strains, and rising numbers of severe cases illustrate dengue's evolving epidemiology and adaptability to changing ecological and social conditions.

The epidemic confirmed dengue's extension into new ecological zones and demographic groups. Autochthonous transmission was documented in parts of Europe, while hyperendemic regions saw the burden shift from children to adolescents and adults. The case-fatality rate was highest in settings with limited access to timely diagnosis and care. Persistent underreporting and misdiagnosis suggest that the true burden was far greater than that recorded.

These developments reaffirm the need for sustained global and regional alignment. The NTD Road Map 2021–2030, the Global Vector Control Response 2017–2030, the Global Arbovirus Initiative launched in 2022 and the Strategic Preparedness and Response Plan for arboviral diseases introduced in 2024 together mark a shift from reactive outbreak control to a proactive, integrated programmatic approach.

The lessons from this record year point to clear priorities: modernizing surveillance to detect shifts in serotype and geography in real time, extending equitable access to vaccines and diagnostics and ensuring that

Les défis restant à relever

La réponse à la dengue reste limitée par les faiblesses systémiques des soins de santé primaires. Les établissements ruraux et périurbains, qui sont souvent les premiers points de contact avec les services de santé, souffrent d'un manque chronique de personnel formé, de moyens de diagnostic et de fournitures essentielles. Ces lacunes retardent la détection et la prise en charge des cas sévères, et l'épidémie de 2024 a montré la rapidité avec laquelle les hôpitaux et les chaînes d'approvisionnement peuvent être submergés.

Maintenir la mobilisation communautaire constitue un autre défi. Les campagnes menées en 2024 en réponse à l'épidémie ont mobilisé un grand nombre de bénévoles, mais la participation a diminué une fois l'urgence passée. Des investissements continus dans la gestion des réceptacles, les opérations de nettoyage et l'éducation dans les écoles sont nécessaires pour maintenir l'impact des mesures de lutte entre les épidémies.

La propagation transfrontalière de la dengue souligne la nécessité d'une coordination régionale plus forte. Les épidémies simultanées dans des pays voisins montrent les limites des réponses nationales fragmentées. Le partage de données en temps utile, l'harmonisation des définitions de cas et les initiatives conjointes de lutte contre les vecteurs sont essentiels pour améliorer la préparation et la riposte au-delà des frontières.

Note de la rédaction

La charge record de la dengue en 2024 a marqué un tournant dans la trajectoire mondiale des arboviroses. Plus de 14 millions de cas et 11 000 décès ont été signalés dans les 6 Régions de l'OMS, faisant de 2024 l'année où la charge de la maladie a été la plus étendue et la plus sévère. La transmission s'est largement répandue et prolongée dans le temps, bien au-delà des pics saisonniers observés habituellement. La circulation simultanée des 4 sérotypes, les changements de souches dominantes et l'augmentation du nombre de cas sévères illustrent l'évolution épidémiologique de la dengue et sa capacité d'adaptation aux contextes écologiques et sociaux changeants.

Cette épidémie a montré que la dengue s'était propagée à de nouvelles zones écologiques et touchait de nouveaux groupes démographiques. Une transmission autochtone a été documentée dans certaines parties de l'Europe, tandis que dans les régions d'hyperendémie, la charge de morbidité qui touchait auparavant les enfants concerne désormais les adolescents et les adultes. Le taux de létalité le plus élevé a été observé dans les milieux où l'accès au diagnostic et aux soins en temps utile était limité. La sous-notification persistante et les erreurs de diagnostic suggèrent que la charge réelle a été bien plus importante que celle enregistrée.

Ces constats réaffirment la nécessité d'une action concertée durable à l'échelle mondiale et régionale. La Feuille de route pour les MTN 2021–2030, l'Action mondiale pour lutter contre les vecteurs 2017–2030, l'Initiative mondiale de lutte contre les arbovirus lancée en 2022 et le Plan stratégique de préparation et de riposte aux arboviroses introduit en 2024 marquent ensemble le passage d'une lutte réactive contre les épidémies à une approche programmatique proactive et intégrée.

Les enseignements tirés de cette année record mettent en évidence des priorités claires: moderniser la surveillance afin de détecter en temps réel les changements de sérotype et de répartition géographique, étendre l'accès équitable aux vaccins

new vector control tools are matched by stable financing and local capacity. Effective dengue control depends not only on technical innovation but also on governance, sustained funding and community trust and support.

The events of the year reveal both the fragility of unprepared systems and the resilience of those with strong public health foundations. Continued investment in early warning systems, integrated vector management and planning according to climate will determine whether this represents an exceptional episode or the beginning of a new global baseline for dengue. ■

et aux moyens de diagnostic, et veiller à ce que les nouveaux outils s'accompagnent d'un financement stable et de capacités locales. L'efficacité de la lutte contre la dengue dépend non seulement de l'innovation technique, mais aussi de la gouvernance, d'un financement durable et de la confiance et du soutien des communautés.

Les événements de 2024 révèlent à la fois la fragilité des systèmes non préparés et la résilience de ceux qui reposent sur des bases solides en matière de santé publique. La poursuite des investissements dans les systèmes d'alerte précoce, la gestion intégrée des vecteurs et la planification en fonction du climat détermineront s'il s'agit d'un épisode exceptionnel ou du début d'une nouvelle réalité mondiale pour la dengue. ■